جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : علا رمضان محمد رزق
المحافظة : الفيوم **الحي / المدينة :** الفيوم **العنوان :** علوايه سعاده- الصوفى
رقم البطاقة : 28502042300145 **رقم التليفون :** 01097063670 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 20-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 04-02-1985 **المهنة :** بدون عمل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

المقر بما فيه
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: علا رمضان محمد رزق
National ID: 28502042300145

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Supportive and palliative Treatment**

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





National ID · Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

MINISTRY OF HEALTH AND POPULATION
SPECIALIZED MEDICAL CENTER
SOUHAG CANCER CENTER

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مركز أورام سوهاج

Patient Name	: السيده / علا رمضان محمد رزق	Request No.	: 110111610
Patient No.	: 28502042300145	Request Date	: 25/08/2024
Path No.	: 6295/2024	Verification Date	: 04/09/2024
Sex	: Female	Financial Category	: مبادرة
Age	:	Department	: مبادرة اورام ثدي - سوهاج
Referreing Doc	: Maro		

Pathology Report

CLINICAL DIAGNOSIS: Right breast mass at 10 o'clock towards axillary tail.

NATURE OF SPECIMEN: TCNB.

GROSS EXAMINATION : The specimen consists of 4 tissue cores (1.5cm long, each), grayish in color, totally submitted in one cassette.

MICROSCOPIC EXAMINATION: Sections revealed infiltration by atypical epithelial cells arranged in cords, nests, the cells show pleomorphism, hyperchromatic nuclei and rare mitosis, the stroma is desmoplastic.

DIAGNOSIS:
Labeled as right breast mass 10 o'clock towards axillary tail, TCNB:
- Features of invasive duct carcinoma, NST, GII.
- No ductal carcinoma in-situ component could be detected in examined section.

Signature
Pathologist.Dr: Ghada Mostafa
Dr. Cherry Gamal

N.B : Specimens received at the department of pathology are examined and sampled for diagnostic purposes.The specimens are normally held for four weeks and then disposed.

سوهاج : شارع كورنيش النيل القبلى مدينة سوهاج الطبية - تليفون : ٠٩٣٢١١٠٩٠١ : ٠٩٣٢١١٠٩٠٧ - فاكس : ٠٩٣٢١١٠٦٥٣
E-MAIL : AWRAM2017@GMAIL.COM

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Name: علا رمضان محمد **MR. :** 4246	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient is a 40-year-old female who presented to the emergency department on 8/8 with a diagnosis of HER2-negative breast cancer. She underwent a simple mastectomy with a pathological stage of PT2 N0 and received adjuvant chemotherapy. She has continued treatment with Zoladex and Femara, and today she was seen for her Femara dose and to discuss continuation of therapy in the coming months.

Zoladex was administered on 4/5/2026 with the next dose scheduled for 27/7/2026. The patient is also receiving Femara with supportive therapy. A 3-month annual assessment is planned, and the current status is reported as stable.

A CT chest performed on 27/7/2026 revealed bilateral deep cervical and bilateral submandibular lymphadenopathy. In August 2026 the patient was found to be free of disease and is continuing Femara for an additional two months.

تحريرا في ,

التاريخ :	21-09-2026	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : علياء احمد أبو النصر شهاب الدين

يعتمد ,

Patient Name	: الأستاذه / علا رمضان محمد رزق	Request No.	: 13004677
Patient No.	: 28502042300145	Request Date	: 06/11/2024
Path No.	: 4273/24	Verification Date	: 25/11/2024
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 39 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data:
Right breast masses.

Nature of the specimen:
Right Simple mastectomy and sentenil lymph node biopsy specimens , collected at 6/11/2024.

Gross Examination:
Two specimens were recived :
-Sentenil lymph node biopsy specimen :Multiple fibrofatty tissue pieces measured 3x3 cm collectively enclosing 2 nodules measured 1.5x1x0.5 cm and 0.5x0.5x0.5 cm.
-Simple mastectomy specimen measured 19x13x5 cm with covering skin elipse measured 19x13 cm .
- Tumor extent
  - Number: Two UOQ ill defined greyish white firm masses.
  - Size:2.8x2x1.5 cm and 0.4x0.4x0.3 cm.
- Distance from margins:The larger mass was located 0.2 cm from deep margin (inked). The distance between the two masses was 2.5 cm.
- Frozen section:
-Free SLNs (0/2).
- Gross key:

1,2) The larger mass with inked deep margin.
3) Area inbetween two masses.
4) Smaller mass.
5) Nipple and areola.
6) Sentenil lymph nodes.
Gross done by Dr.Duaa Mohammed.

Verified by :
dr.esraa magdy

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

GUSTAVE ROUSSY
INTERNATIONAL

Patient Name: Ola Ramadan Mohamed Rezk	Date : 23/07/2025
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 40 Year(s)
Medical ID: 3342/2024 470	Pat. ID: 79802

LEFT BREAST MAMMOGRAPHY WITH BILATERAL UITRASOUND

INDICATION:
Right MRM

TECHNIQUE:

- Left breast MLO and CC views
- Bilateral ultrasound

REPORT:

- Dense parenchyma, (ACR C).
- No spiculated masses or grouped microcalcifications.
- Complementary U/S showed no left breast solid or cystic masses
- Normal skin thickness and nipple-areola complex of the left breast.
- A benign calcification is seen.
- Left nonspecific axillary nodes, with preserved fatty hila and uniform cortical thickness.
- Free right operative bed with no evidence of recurrent mass lesions, and free infra and supra clavicular regions

OPINION:

- Right MRM with free operative bed.
- Apart from a benign calcification, essentially normal study of the left breast, (BIRADS 2).

Best regards,
Dr. Mahi Mokhtar

Ultrasound
[[DOCTYPE:ULTRASOUND]]

NILE
SCAN & LABS

مركز النيل للأشعة و التحاليل

Name : Alaa Ramadan Mohammed
Branch : Dokki
Ref.Physician Prof : Gostaf Roseh Hospital

Date : 09-08-2025 10:03
Medical No. : 171222

$Tc^{99}m$ MDP SKELETAL SCINTIGRAPHY

History:

- 40-year-old lady, with right breast cancer, referred for follow up.

Technique:

- Anterior and posterior whole body scans were acquired 2 hours post injection of the tracer.

Findings:

Compared to prior study dated 17/10/02024:

- Still no abnormal active or cold focal bony lesions that may account for metastatic bone disease could be seen allover the surveyed skeleton.
- Pelvic positional tilt is noted.

Impression:

- The skeleton is keeping free from metastases.

Best regards,
Dr. Alaa Nagi, MD
Nuclear Medicine

NILE DIAGNOSTIC CENTER

Bone Scan
[[DOCTYPE:BONE_SCAN]]

الفيوم - مديرية التضامن الاجتماعى
الجمعية لرعاية مرضى الأورام
المشهرة برقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٠

FOC
مركز أورام الفيوم

اسم المريض:- علا رمضان محمد التاريخ :-2024/08/11

الطبيب المعالج:- أ.د/

Sono-mamography examination of Bilateral Breast Revealed

ACR B: scattered fibro glandular breast tissue

Right breast:-

- *UOQ irregular shaped highly dense lesion with speculated margins and coarse heterogeneous micro-calcifications seen at 10 o'clock towards the axillary tail , measuring about (19 x 17 mm) in its maximum transverse diameters. Such lesion showed increased peripheral vascularity on color Doppler study.*
- Normal appearance of lactiferous ducts with no evidence of focal lesions within.
- Average skin thickness.
- No abnormal vascular pattern.
- Normal appearance of retro-mammary area and pectoral muscles.
- No intra-mammary Lymphadenopathy.
- **Few nonspecific axillary lymph nodes are noted. They showed regular outlines and preserved fatty hilum**

Left breast:-

- Normal fibro-glandular pattern with no evidence of solid masses or cystic lesions could be detected.
- Normal appearance of lactiferous ducts with no evidence of focal lesions within.
- Increased skin thickness.
- No abnormal vascular pattern.
- Normal appearance of retro-mammary area and pectoral muscles.
- **Few nonspecific axillary lymph nodes are noted. They showed regular outlines and preserved fatty hilum**

شارع النيوى المهندس - خلف مستشفى الصدر - الفيوم - مصر
محمول : ٠١٠٦٩٦٩١٠٤٥
foc600600@gmail.com

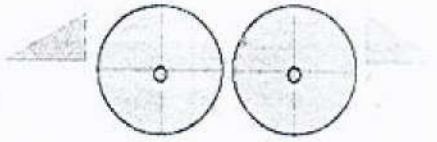
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان

MDT form

A-Patient ID:
1- Name : علا رمضان محمد رزق
Sex: Female
3- Medical number: 83234579
Old Med : 3342-2024
2-ID number:
Patient Age : 40 Y



Family history	Family History -Ve	Phone	Phone 01097603670	BMI	BMI	REASON OF MDT	REASON OF MDT
marital status	Marital Status MARRID	NRS Score	NRS Score	GROUP	GROUP B	Date of MDT	Date Of MDT 05/12/2024
Co morbidity	Co Morbidity cardiac,MVP	Menopausal status	Menopausal Status PRETMENOPAUSAL	Initial STAGE	Initial STAGE		

Clinical data

Breast Imaging :
rt UOQ mass 19x17 mm+microcalcification
few non specific LN

Mets Workup :
cap:illd efined lucent areas of bilateral iliac bones+L3 vertebral body subtle lesio+sclerotic focus
bone scan:free

BX	ER	PR	Her 2 Neu	SISH	Ki67
IDC	8/8	8/8	0		25
BX COMMENT:	ER COMMENT:	PR COMMENT:	Her 2 Neu COMMENT:	SISH COMMENT :	

T	N	M
2m	0	0

Sonomammography
cesm:RT BREAST AXILLARY TAIL MASS SHOWING MODERATE MASS ENHANCEMENT WITH ANTERIOR ENHANCING NODULES 86MM, NIPPLE RETRACTION WITH RETROAREOLAR NON MASS ENHANCEMENT

PATIENT HISTORY
upfront simple mastectomy+SLNB: bifocal mixed IDC+ILC pt2(2.8cm,0.4cm)
LN 0/2
free deep margin

MDT OUTCOME & PLAN

MDT OUTCOME & PLAN
for 1-adjuvant taxotere endoxanx4
2-zoladex aromatase inhibitor + Zometa 13m

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	MEDICAL ONCOLOGY د/ الاء جميل	RADIOLOGY	RADIOLOGY د/ رهاب البخري
SURGERY	SURGERY د/ احمد فتح الله	PATHOLOGY	PATHOLOGY
Psychiatric	Psychiatric	Nutrition	Nutrition

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]